

PHOENIX evaluatiestudie

Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

Instrument voor Zorgprofessionals

Deelnemerscode: HCP-PRE-01

Toegewezen casussen: **C01** (28-jarige softwareontwikkelaar) en **C02** (34-jarige administratief medewerker in de zorg)

Studie	Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX)
Instelling	Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeker	Stijn Van Severen (masterproefstudent)
Promotoren	Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe
Contact	stijn.vanseveren@ugent.be
Geschatte duur	Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen

Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming. Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

Contents

1	Instructiepagina	3
2	Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen	5
3	Deel 2: Initieel observatiemodel	8
4	Deel 3: Prioritering van behandeldoelen	11
5	Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica	14
6	Deel 5: Mobiele coachingsboodschap	17
7	Afronding en terugbezorging	20

1 Instructiepagina

PHOENIX is een multi-agentsysteem dat een vrije klachttekst omzet in een gestructureerde klinische redenering via vijf opeenvolgende stappen. In deze bundel voert u diezelfde vijf stappen onafhankelijk uit voor uw twee toegewezen casussen. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Stap	Klinische taak	Wat u doet	Richttijd
1	Operationalisering	Noteer 2–6 criteriumlabels voor actuele probleemdimensies	≈ 6 min
2	Initieel observatiemodel	Genereer 3–5 biopsychosociale predictor-labels (EMA-geschied)	≈ 6 min
3	Behandeldoelprioritering	Rangschik de 5 standaardpredictoren van hoog naar laag	≈ 7 min
4	Verfijnd observatiemodel	Selecteer exact 5 EMA-items uit de lijst van 20	≈ 8 min
5	Mobiele coaching	Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app	≈ 8 min
Totaal (2 casussen)			35–45 min

Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blind beoordeling.

EMA-principes (relevant voor Deel 2 en Deel 4)

Ecological Momentary Assessment (EMA) meet dagelijkse schommelingen via een mobiele app. Elke EMA-variabele moet aan vier vereisten voldoen:

- **Dagelijks rapporteerbaar** via een korte vraag op de smartphone.
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste diagnose, trait of achtergrondkenmerk.
- **Meetbaar in een eenvoudig format:** ja/nee, aantal, minuten of een 0–10 score.
- **Klinisch relevant voor opvolging:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.

In **Deel 2** genereert u zelf predictorlabels. In **Deel 4** zijn de 20 kandidaat-items reeds uitgewerkt als dagelijkse EMA-items; u selecteert de meest geschikte 5.

2 Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen

Instructies Deel 1

Opdracht: identificeer de belangrijkste actuele probleemdimensies in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

Wat telt als criterium? Een klinisch relevante probleemdimensie die:

- momenteel aanwezig is in de casus,
- inhoudelijk apart te onderscheiden is van andere probleemdimensies,
- in principe herhaald meetbaar zou kunnen zijn.

Antwoordformat: label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar

“De afgelopen twee maanden geraak ik 's avonds heel moeilijk in slaap. Mijn hoofd blijft maar doorgaan over alles wat ik nog moet doen – deadlines, onafgewerkte taken, gesprekken die ik nog moet voeren. Zelfs als ik uitgeput ben, krijg ik die gedachten niet uitgezet. Ik merk ook dat ik minder plezier beleef aan sociale momenten. Ik ga nog wel naar afspraken met vrienden, maar ik voel me er afstandelijk en niet echt betrokken. Mijn nek en schouders staan bovendien bijna voortdurend gespannen en pijnlijk, wat volgens mijn huisarts waarschijnlijk stressgerelateerd is.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 6 Label (2–5 woorden): _____

Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg

“Ongeveer drie maanden geleden begon ik plots episodes te krijgen waarbij mijn hart tekeergaat, ik het gevoel heb dat ik geen lucht krijg en ik er zeker van ben dat er iets ernstig misloopt. Die episodes zijn heel beangstigend en kunnen zelfs optreden wanneer ik thuis rustig neerzit. Sindsdien ben ik bang geworden om zo’n episode in het openbaar te krijgen en vermijd ik supermarkten, openbaar vervoer en drukke plaatsen. Ik heb mij al meerdere keren ziek gemeld omdat ik bang was dat het op het werk zou gebeuren. Ik weet rationeel dat die situaties niet gevaarlijk zijn, maar de angst blijft overheersen.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 6 Label (2–5 woorden): _____

3 Deel 2: Initieel observatiemodel

Instructies Deel 2

Opdracht: genereer **3–5 biopsychosociale predictorlabels** die een initieel observatiemodel vormen voor deze casus.

Wat telt als predictor? Een veranderbare factor die:

- klinisch plausibel samenhangt met een of meerdere criteria,
- geschikt is voor **dagelijkse Ecological Momentary Assessment (EMA)**,
- door de persoon zelf eenvoudig via een mobiele app kan worden gerapporteerd.

Antwoordformat: enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar – Deel 2

28-jarige softwareontwikkelaar; duur: 2 maanden. Inslaapproblemen, cognitieve hyperarousal bij het slapengaan, sociale anhedonie en stressgerelateerde spierspanning.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Inslaapproblemen
- **CR-2** Cognitieve hyperarousal
- **CR-3** Sociale anhedonie
- **CR-4** Stressgerelateerde spierspanning

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 2

34-jarige administratief medewerker in de zorg; duur: 3 maanden. Recidiverende paniekepisoden, anticipatieangst, situationele vermijding en beroepsmatige interferentie.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Recidiverende paniekepisoden
- **CR-2** Anticipatieangst
- **CR-3** Situationele vermijding
- **CR-4** Beroepsmatige interferentie

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

4 Deel 3: Prioritering van behandeldoelen

Instructies Deel 3

Opdracht: rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** klinische prioriteit als behandeldoel.

Gebruik voor uw rangschikking:

- de 21-daagse monitoring,
- de bipartiete netwerkstructuur,
- de mate waarin een predictor meerdere criteria kan beïnvloeden.

Visuele sleutel van het netwerk: *predictoren links → criteria rechts*

 **Rood = risicofactor** (predictor *vergroot* criterium)  **Blauw = beschermend**
(predictor *verkleint* criterium)

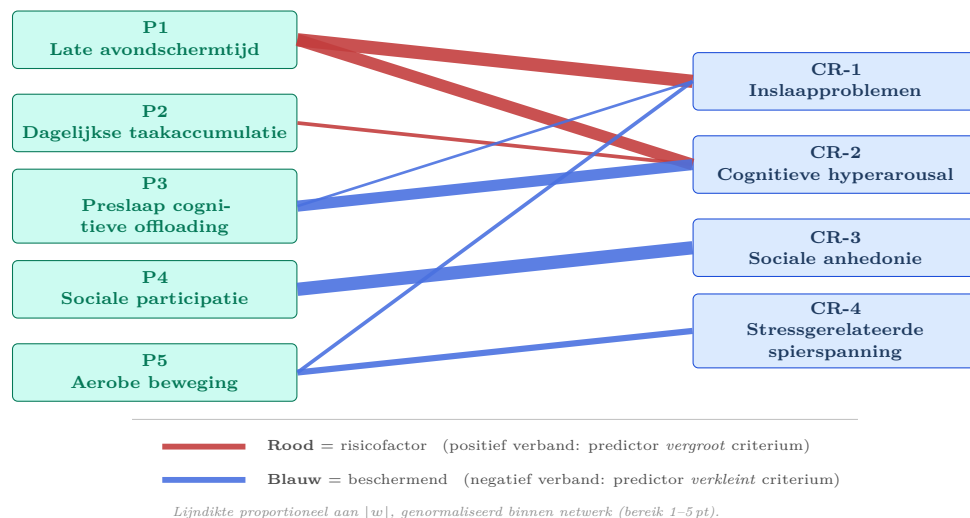
Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van de relatie ($|w|$, bereik 0–1).

Antwoordformat: vul alle prioriteitslijnen in, van 1 tot en met 5.

Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar – Deel 3

Inslaapproblemen, cognitieve hyperarousal bij het slapengaan, sociale anhedonie en stressgerelateerde spierspanning. Duur: 2 maanden.

21-daagse monitoring: Schermtijd na 22.00 uur: 16/21 avonden (gem. 78 min). Openstaande taken: gem. 6,2 per dag. Sociale activiteiten: 2,1/week (beleving 2,3/10). Preslaap offloading toegepast: 3/21 avonden. Lichamelijke activiteit: gem. 0,7 sessies/week.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Late avondschermtijd, P2: Dagelijkse taakaccumulatie, P3: Preslaap cognitieve offloading, P4: Sociale participatie, P5: Aerobe beweging

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

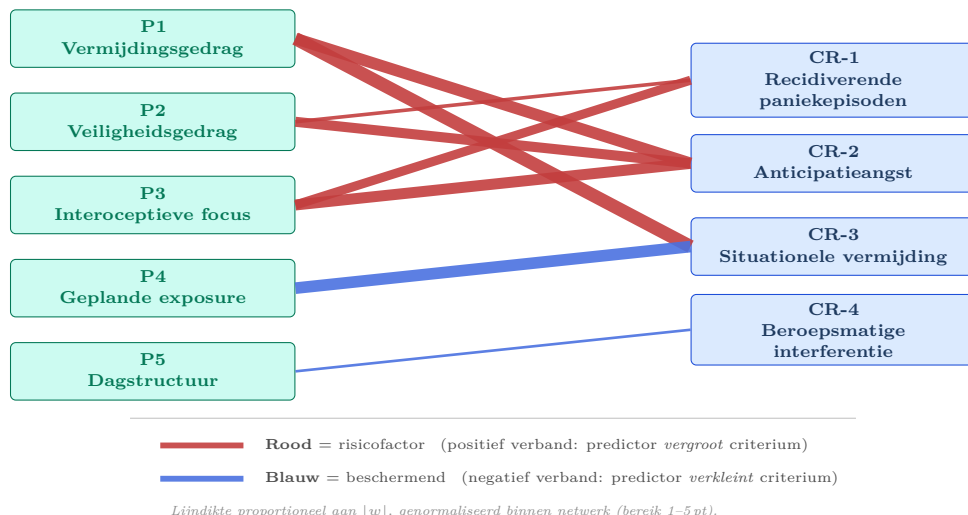
Prioriteit 4

Prioriteit 5

Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 3

Recidiverende paniekepisoden, anticipatieangst, situationele vermijding en beroepsmatige interferentie.
Duur: 3 maanden.

21-daagse monitoring: Paniekepisoden: gem. 2,3/week. Vermijdingsepisodes: gem. 4,1/dag. Veiligheidsgedrag: gem. 8,7/dag. Geplande exposurepogingen: gem. 0,3/dag. Werkaanwezigheid: 60%. Verwachte angst in publieke settings: 7,8/10.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Vermijdingsgedrag, P2: Veiligheidsgedrag, P3: Interoceptieve focus, P4: Geplande exposure, P5: Dagstructuur

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica

Instructies Deel 4

Opdracht: selecteer per casus **exact 5 EMA-items** uit een lijst van 20.

Wat bootst dit deel na? PHOENIX verfijnt het observatiemodel via een **breadth-first update-logica**: vanuit de reeds geprioriteerde behandeldoelen wordt gezocht naar de meest geschikte, direct meetbare subpredictoren voor de volgende EMA-cyclus.

Selectieprincipe:

- start vanuit de standaardbehandeldoelen hieronder,
- kies de 5 dagelijkse EMA-items die daar het best op aansluiten,
- verkies klinisch relevante breedte boven irrelevante of perifere items,
- noteer **geen** toelichting of extra commentaar.

Antwoordformat: vink **exact 5** items aan.

Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar – Deel 4**Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:**

1. **Schermtijd na 22.00 uur** (*hoogste impact op CR-1 en CR-2; monitoring toont consequent laat gebruik (16/21 avonden)*)
2. **Preslaap cognitieve offloading** (*nauwelijks ingezet ondanks duidelijke taakaccumulatie; rechtstreeks relevant voor CR-2*)
3. **Aerobe beweging** (*zeer lage frequentie (0,7 sessies/week); potentieel effect op CR-1 en CR-4*)

Opdracht: selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Cafeïne-inname na 16.00 uur (aantal)
2. ☐ Schermtijd na 22:00 uur (min)
3. ☐ Aantal dutjes overdag (min)
4. ☐ Preslaap cognitieve offloading toegepast (ja/nee)
5. ☐ Tijd in bed voor het opstaan (min)
6. ☐ Aerobe beweging vandaag (min)
7. ☐ Aantal sociale afspraken gepland (aantal)
8. ☐ Nek- en schouderspanning in de namiddag (0–10)
9. ☐ Blootstelling aan blauw licht voor het slapengaan (min)
10. ☐ Piekeren over sociale afwijzing (0–10)
11. ☐ Aantal maaltijden na 21.00 uur (aantal)
12. ☐ Ochtendlichtblootstelling (min)
13. ☐ Preslaap ontspanningsritueel uitgevoerd (ja/nee)
14. ☐ Werkuren vandaag (uren)
15. ☐ Alcoholinname in de avond (aantal)
16. ☐ Slaapduur afgelopen nacht (uren)
17. ☐ Aantal onbeantwoorde berichten (aantal)
18. ☐ Pijnintensiteit lage rug (0–10)
19. ☐ Hydratatie vandaag (glazen)
20. ☐ Concentratie overdag (0–10)

Totaal geselecteerd: _____ / 5

Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 4**Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:**

1. **Geplande exposure** (*nagenoeg afwezig in de monitoring (0,3/dag); rechtstreeks aangrijpingspunt voor vermijdingsreductie*)
2. **Veiligheidsgedrag** (*hoge frequentie (8,7/dag) onderhoudt anticipatieangst en paniekverwachting*)
3. **Interoceptieve focus** (*verhoogde aandacht voor lichamelijke sensaties voedt escalatie van CR-1 en CR-2*)

Opdracht: selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Cafeïne-inname voor 12.00 uur (aantal)
2. ☐ Geplande exposure-oefening uitgevoerd (ja/nee)
3. ☐ Rusthartslag bij ontwaken (slagen/min)
4. ☐ Spierspanning in schouders (0–10)
5. ☐ Veiligheidsgedrag frequentie (0–10)
6. ☐ Sociale contacten vandaag (aantal)
7. ☐ Lichamelijke sensaties zonder reactie geobserveerd (min)
8. ☐ Stress op het werk (0–10)
9. ☐ Inslaaptijd afgelopen nacht (min)
10. ☐ Vermijdingssituatie betreden ondanks angst (ja/nee)
11. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
12. ☐ Plezier in vrijetijdsactiviteit (0–10)
13. ☐ Aantal dutjes overdag (min)
14. ☐ Eetlust vandaag (0–10)
15. ☐ Anticipatieangst voor gevreesde situatie (0–10)
16. ☐ Stemningsval in de namiddag (0–10)
17. ☐ Stapelteller vandaag (aantal)
18. ☐ Concentratie tijdens administratie (0–10)
19. ☐ Alcoholinname vanavond (aantal)
20. ☐ Tijd buitenshuis zonder ondersteuning (min)

Totaal geselecteerd: _____ / 5

6 Deel 5: Mobiele coachingsboodschap

Instructies Deel 5

Opdracht: schrijf een korte, patientgerichte coachingsboodschap die rechtstreeks in de mobiele applicatie kan verschijnen.

Gebruik hiervoor:

- het primaire probleem van de casus,
- het geselecteerde behandeldoel,
- de voornaamste barriere,
- de aangegeven copingstrategie.

De boodschap hoort:

- compact genoeg te zijn voor een mobiel scherm,
- warm en professioneel te klinken,
- een concrete eerstvolgende stap te bevatten,
- rechtstreeks tot de persoon gericht te zijn.

Werkvoorbeeld (niet gerelateerd aan een studiecaser):

Context: verpleegkundige met het doel om opnieuw korte beweegmomenten in te bouwen; barriere = vermoeidheid na de shift; coping = een vaste 10-minutenwandeling koppelen aan het thuiskomen.

Voorbeeldboodschap:

“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten, zonder jezelf meer op te leggen dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”

Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar – Deel 5

Primair probleem

Moeizaam inslapen door een overactieve geest en aanhoudende spanning in de avond.

Behandeldoel

Schermtijd in de late avond reduceren en een vaste afschakelroutine installeren.

Voornaamste barriere

Lage zelfeffectiviteit: schermgebruik voelt als de enige haalbare manier om na het werk te decomprimeren.

Copingstrategie

Implementatie-intentie met substitutie: vervang de laatste 30 minuten schermtijd door een korte schrijf- of bewegingsroutine voor het slapengaan.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 5**Primair probleem**

Paniekangst leidt tot toenemende vermijding en duidelijke hinder in het dagelijks functioneren.

Behandeldoel

Geplande exposure aan gevreesde situaties in een hanteerbare, stapsgewijze opbouw.

Voornaamste barriere

Sterke negatieve uitkomstverwachting: de persoon verwacht dat betreden van de situatie onvermijdelijk tot een onbeheersbare paniecreactie zal leiden.

Copingstrategie

Werk met een concrete exposurehiërarchie en een vooraf afgesproken copingzin per stap.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casus 1 en Casus 2).

Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 5 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-01

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.